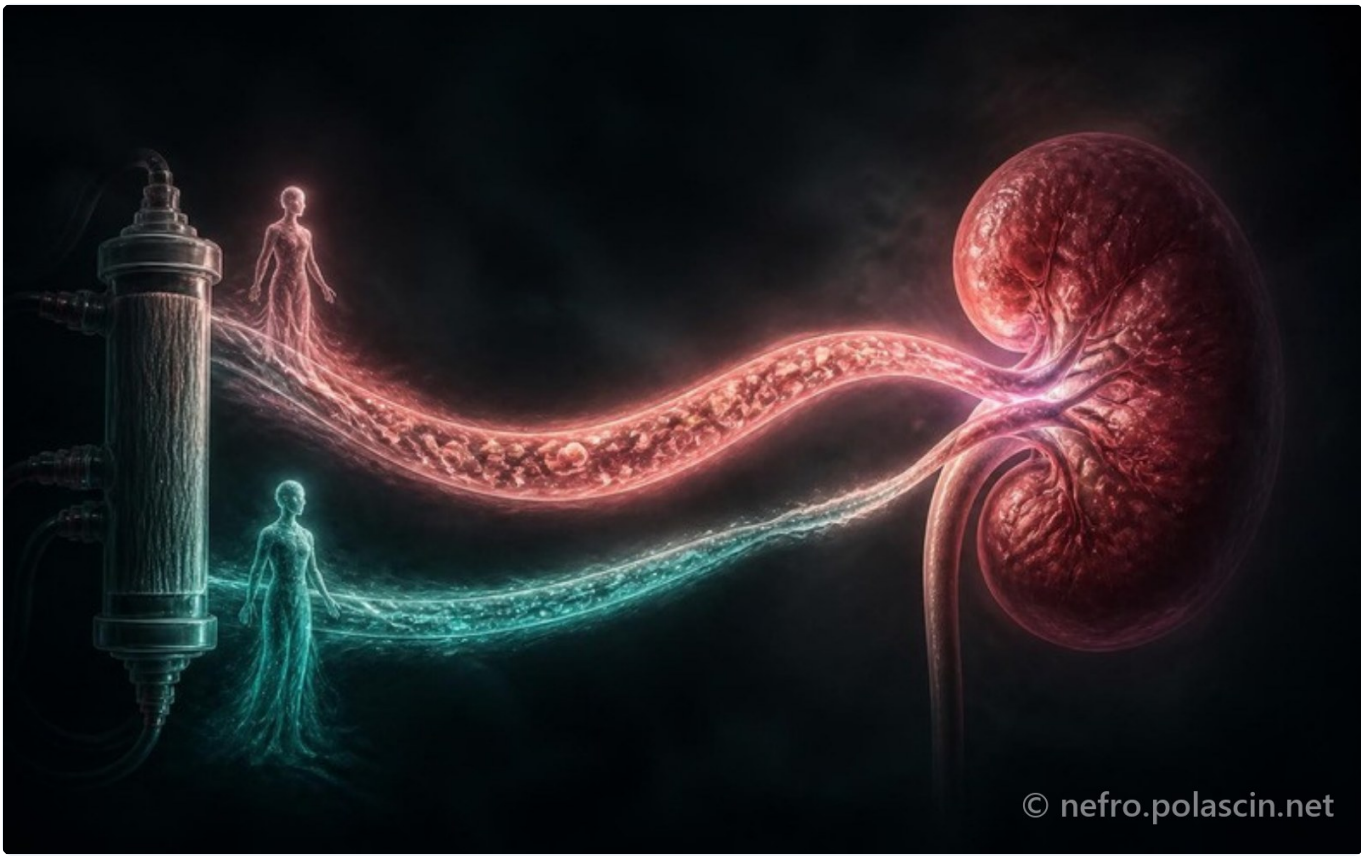
Rodové rozdiely v dialýze a transplantácii: Európa vs USA podľa ERA Registry a USRDS

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 19.06.2026



Ilustračná scéna. Cesta k transplantácii nie je pre všetkých rovnako priechodná – registre ten rozdiel dokumentujú.

Chronické zlyhávanie obličiek vedie k potrebe liečby obličkovej náhrady (KRT, *kidney replacement therapy*). V klinickej praxi však narážame na rozdiely medzi pohlaviami aj medzi krajinami, najmä v tom, kto sa na KRT dostane, aké sú šance na transplantáciu a aká je následná mortalita. Analýza publikovaná v *Nephrology Dialysis Transplantation* porovnáva Európu a USA práve v týchto parametroch a ukazuje, že rozdiely sú výraznejšie najmä u žien.

Čo porovnávali

Autori analyzovali dáta za rok **2022** z dvoch veľkých registrov:

- **ERA Registry** pre Európu,
- **USRDS** pre USA.

Sledovali štyri hlavné výstupy, vždy osobitne pre ženy a mužov:

1. **incidenciu KRT**, teda koľko ľudí začalo KRT,
2. **prevalenciu KRT**, teda koľko ľudí bolo na KRT ku koncu roka,
3. **mieru transplantácií**,
4. **mortalitu na KRT**.

Hlavné výsledky

1) Incidencia KRT: USA výrazne vyššie, rozdiel väčší u žien

V roku 2022 bola **incidencia KRT v USA 388,7 na milión obyvateľov**, kým v Európe **146,2 na milión**

obyvateľov. To predstavuje približne **2,7-násobný rozdiel**.

Rozdiel bol ešte výraznejší u žien:

- **ženy v USA** mali incidenciu KRT **3,2-krát vyššiu** než ženy v Európe,
- **muži v USA** mali incidenciu KRT **2,4-krát vyššiu** než muži v Európe.

Podiel žien medzi pacientmi, ktorí začali KRT, bol v Európe nižší:

- **35 %** v Európe,
- **41 %** v USA.

2) Trendy 2013 až 2022: v Európe stabilita u žien, rast u mužov

V Európe bola incidencia KRT u žien medzi rokmi 2013 a 2022 v podstate **stabilná** (+0,1 % ročne), zatiaľ čo u mužov **stúpala** (+1,1 % ročne).

V USA rástla incidencia KRT podobne u žien (+0,2 % ročne) aj u mužov (+0,3 % ročne).

3) Prevalencia KRT: USA približne dvojnásobok Európy

Ku dňu 31. 12. 2022 bola **prevalencia KRT v USA 2444,2 na milión obyvateľov**, zatiaľ čo v Európe **1218,6 na milión obyvateľov**, teda približne **2-násobok**.

Podľa pohlavia:

- prevalencia u žien bola v USA **2,2-krát vyššia**,
- u mužov **1,9-krát vyššia**.

Aj tu tvorili ženy v Európe menší podiel populácie na KRT:

- **38 %** v Európe,
- **41 %** v USA.

4) Transplantácie: USA vyššie miery, podiel žien podobný

Miera transplantácií bola v USA **79,1 na milión obyvateľov** a v Európe **45,4 na milión obyvateľov**, teda približne **1,7-násobne vyššia**.

Pri rozdelení podľa pohlavia:

- u žien bola miera transplantácií v USA približne **1,9-krát vyššia**,
- u mužov **1,7-krát vyššia**.

Podiel žien medzi príjemcami transplantácie bol v oboch regiónoch podobný:

- **37 %** v Európe,
- **39 %** v USA.

5) Mortalita na KRT: USA vyššia, vzťah k pohlaviu sa líši podľa regiónu

Celková mortalita na KRT bola v USA **145,0 na 1000 paciento-rokov**, zatiaľ čo v Európe **100,5 na 1000 paciento-rokov**, teda približne **1,5-násobne vyššia**.

Pri porovnaní pohlaví sa ukázal rozdielny vzorec podľa regiónu:

- **v Európe** mali ženy mortalitu **93,7/1000 paciento-rokov**, muži **104,6/1000 paciento-rokov**, teda ženy nižšiu,
- **v USA** mali ženy mortalitu **148,9/1000 paciento-rokov**, muži **142,2/1000 paciento-rokov**, teda ženy vyššiu.

Ako si to preniesť do praxe

Štúdia neodhaľuje konkrétny biologický mechanizmus. Dokumentuje rozdiely v poskytovaní a priebehu KRT medzi regiónmi a medzi ženami a mužmi. Pre klinickú prax z toho vyplýva niekoľko otázok:

1. **Kto sa dostane na KRT a kedy?** Nižší podiel žien medzi pacientmi začínajúcimi KRT v Európe môže odrážať rozdiely v dostupnosti, rozhodovaní, komorbiditách alebo v odosielaní pacientov.
2. **Aký je výsledok po začatí KRT?** Vyššia mortalita v USA môže naznačovať rozdiely v komorbiditách, zložení populácie aj v samotnom procese liečby.
3. **Prečo sa mortalita žien líši podľa regiónu?** Tento nález podporuje hypotézu, že pohlavie pôsobí cez viacero mechanizmov, ktoré nemusia byť rovnaké v rôznych zdravotníckych systémoch.

V ambulantnej nefrológii sa to dá pretaviť do konkrétnych kontrolných bodov: včasné plánovanie KRT, dôsledná práca s komorbiditami a systematické sledovanie výsledkov liečby u oboch pohlaví.

Limity

Aj keď štúdia využíva veľké registre, porovnania naprieč kontinentmi sú vždy ovplyvnené rozdielmi v:

- definíciách a kódovaní,
- dostupnosti a politike transplantácií,
- manažmente komorbidít,
- načasovaní prechodu do KRT.

Výsledky je preto vhodnejšie chápať ako **epidemiologický signál**, nie ako priame kauzálne vysvetlenie.

Záver

V roku 2022 boli v USA vyššie incidencie aj prevalencie KRT, vyššia miera transplantácií a zároveň vyššia mortalita na KRT v porovnaní s Európou. Rozdiely medzi regiónmi boli väčšie u žien a vzťah medzi pohlavím a mortalitou na KRT sa medzi Európou a USA líšil.

Zdroj: *Nephrology Dialysis Transplantation, článok „Kidney replacement therapy for men and women according to the ERA Registry and the USRDS“. Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=rodove-rozdiely-dialyza-transplantacia-era-usrds · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.